

Patienteninformation

ZAHNEXTRAKTION · EINZELZAHNENTFERNUNG

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, dieses Dokument erklärt die Entfernung eines einzelnen Zahnes. Es dient der Vorbereitung auf das persönliche Aufklärungsgespräch und fasst Ablauf, Alternativen, Betäubungsmöglichkeiten, Risiken und Verhalten nach dem Eingriff zusammen. Bitte lesen Sie die Seite vor dem Termin einmal vollständig durch.

1 · WARUM SOLL DER ZAHN ENTFERNT WERDEN?

Häufige Gründe

- **Tiefe Karies:** Die Zahnschubstanz ist so stark zerstört, dass ein stabiler Aufbau nicht mehr sinnvoll möglich ist.
- **Wurzelriss:** Ein Riss reicht bis in die Wurzel und macht den Zahn langfristig nicht erhaltungswürdig.
- **Fortgeschrittene Parodontitis:** Der Knochenhalt ist stark reduziert, der Zahn ist gelockert oder wiederholt entzündet.
- **Nicht beherrschbare Entzündung:** Eine Wurzelentzündung oder ein Abszess kann nicht ausreichend zahnhalterhaltend behandelt werden.
- **Prothetischer oder kieferorthopädischer Grund:** Der Zahn steht einer sinnvollen Gesamtplanung im Weg.

Was passiert, wenn man nichts tut?

Das Belassen eines nicht erhaltungswürdigen Zahnes ist grundsätzlich möglich, kann aber je nach Befund erhebliche Nachteile haben.

- Wiederkehrende Schmerzen oder Entzündungen
- Ausbreitung einer Infektion in Knochen, Weichgewebe oder Kieferhöhle
- Weiterer Knochenverlust im späteren Implantat- oder Prothesenbereich
- Schädigung von Nachbarzähnen oder erschwerte spätere Versorgung
- Akute Verschlechterung zu einem ungünstigen Zeitpunkt

2 · WELCHE ALTERNATIVEN GIBT ES?

Zahnerhalt

Wenn der Zahn noch sinnvoll erhaltungsfähig ist, können je nach Befund Wurzelkanalbehandlung, Wurzelkanalrevision, Parodontaltherapie, Aufbau oder Krone Alternativen sein.

Zahn belassen

Eine Nichtbehandlung ist möglich, wenn Sie sich gegen den Eingriff entscheiden. Dabei bleiben Ursache und Risiken aber bestehen. Die individuelle Abwägung wird im Gespräch erklärt.

Zweitmeinung

Wenn die Erhaltungswürdigkeit unklar ist oder mehrere gleichwertige Wege möglich sind, kann eine Rücksprache mit dem Hauszahnarzt oder eine Zweitmeinung sinnvoll sein.

Wichtig: Die Entfernung ist keine Entscheidung gegen eine spätere Versorgung. Häufig ist sie der notwendige erste Schritt, damit Entzündung, Schmerzen oder eine nicht stabile Situation beendet werden können.

3 · WIE LÄUFT DIE ZAHNENTFERNUNG AB?

Einfache Extraktion

Nach vollständiger Betäubung wird der Zahn mit speziellen Instrumenten vorsichtig gelockert und anschließend entfernt. Dabei spüren Sie Druck und Bewegung, aber keinen Schmerz. Danach wird die Wunde gereinigt, die Blutstillung kontrolliert und bei Bedarf vernäht.

Operative Extraktion

Wenn der Zahn tief zerstört, mehrwurzelig, stark gekrümmt oder fest im Knochen verankert ist, wird er schonend operativ entfernt. Dazu kann das Zahnfleisch eröffnet werden. Bei Bedarf tragen wir etwas Knochen ab und teilen den Zahn in mehrere Stücke.

Planwechsel während des Eingriffs: Manchmal zeigt sich erst nach Beginn, dass eine einfache Entfernung nicht sicher oder nicht schonend genug ist. Dann wird auf eine operative Entfernung umgestellt. Ziel bleibt immer: möglichst wenig Druck, möglichst kontrollierte Entfernung.

4 · BETÄUBUNG, SEDIERUNG UND NARKOSE

Ihre Wahlmöglichkeiten im Überblick

Methode	Beschreibung	Kosten
Lokalanästhesie Standard	Wach, kein Schmerz - nur Druck. Bei Schmerzwahrnehmung wird sofort nachbetäubt. ÖPNV nach Hause erlaubt.	Kassenleistung (GKV) bzw. im Behandlungspaket inkl.
Orale Sedierung (Tavor) Komfort	Tablette ca. 60 Min. vorher. Kein Schlaf, deutliche Stressreduktion. Vitalparameter werden überwacht. Begleitperson notwendig, 24 Std. nicht verkehrsfähig. Abholung aus der Praxis verpflichtend.	ca. 80 € Eigenleistung
Dämmerschlaf (i.v.) Komfort	Professionelles Narkoseteam, medikamentös an der Schlaf-Wachgrenze, kooperativ, meist keine Erinnerung. Postop. Aufwachraum mit Vitalüberwachung. Nur dienstags. Nüchtern ab 22 Uhr nichts essen, ab 6 Uhr nichts trinken. Abholung aus der Praxis verpflichtend.	ca. 230 € Eigenleistung
Vollnarkose Komfort	Echter Tiefschlaf, Beatmung über die Nase in die Lunge, keine Wahrnehmung des Eingriffs. Postop. Aufwachraum mit Vitalüberwachung. Nur dienstags. Nüchtern wie Dämmerschlaf. Abholung aus der Praxis verpflichtend.	ca. 450 € Eigenleistung

Standard ist die Lokalanästhesie - für die allermeisten Patienten vollkommen ausreichend. Sedierung ist eine optionale Komfortzubuchung als Eigenleistung. Bei keiner Methode spüren Sie Schmerzen - die Betäubung wirkt vollständig, bevor wir beginnen.

5 · ALLGEMEINE RISIKEN UND KOMPLIKATIONEN

Nachblutung selten, aber wichtig

Leicht blutig gefärbter Speichel am OP-Tag ist häufig. Eine echte Nachblutung bedeutet: frisches Blut läuft dauerhaft nach und lässt sich nicht durch konstanten Druck stoppen.

Trockene Alveole typisch ab Tag 2-5

Der schützende Blutpfropf löst sich zu früh oder bildet sich nicht stabil. Das kann tief sitzende, zum Ohr ausstrahlende Schmerzen und schlechten Geschmack verursachen. Besonders Rauchen erhöht das Risiko.

Infektion

Trotz sorgfältiger Entfernung kann sich die Wunde entzünden. Warnzeichen sind zunehmende Schwellung, Wärme, Eiter, Fieber oder deutlich zunehmende Schmerzen nach anfänglicher Besserung.

Schwellung, Hämatom, eingeschränkte Mundöffnung

Je operativer die Entfernung, desto eher können Schwellung, blauer Fleck oder eingeschränkte Mundöffnung auftreten. Meist ist das vorübergehend.

Wurzelfraktur oder Wurzelrest

Stark gekrümmte, sehr dünne oder vorbehandelte Wurzelanteile können sich lösen. Kleine Wurzelreste können in seltenen Fällen belassen werden, wenn die Entfernung riskanter wäre als die Kontrolle.

Nachbarzahn, Füllung, Krone

Nachbarzähne, Kronen, Brücken oder Füllungen können selten belastet oder beschädigt werden, besonders wenn der zu entfernende Zahn sehr eng steht oder stark zerstört ist.

Knochenkante oder kleine Knochenpartikel

Nach der Heilung können sich kleine scharfe Knochenkanten oder Knochenpartikel bemerkbar machen. Oft glättet sich das von selbst, manchmal wird es kontrolliert oder geglättet.

Sehr seltene Risiken

Allergische Reaktionen, Kreislaufreaktionen, Verschlucken kleiner Fragmente, Kieferbruch bei stark vorgeschädigtem Knochen oder ausgeprägter Entzündung sind sehr selten, müssen aber erwähnt werden.

6 · BESONDERE RISIKEN JE NACH ZAHNREGION

Oberkiefer-Seitenzähne

Die Wurzeln können nahe an der Kieferhöhle liegen. Wird eine MAV eröffnet, wird sie in der Regel sofort verschlossen. Danach gelten Sonderregeln: nicht schnäuzen, Niesen mit offenem Mund, kein Druckausgleich.

Unterkiefer-Seitenzähne

Der Unterkiefernerve kann in der Nähe der Wurzeln verlaufen. Eine vorübergehende Taubheit an Lippe, Kinn oder Zunge ist möglich. Dauerhafte Gefühlsstörung ist selten.

Frontzahnbereich

Bei sichtbarer Lücke sollte ein Provisorium vor dem Extraktionstermin mit dem Hauszahnarzt organisiert werden. Wir können ein solches Provisorium nicht spontan am OP-Tag herstellen.

7 · VORERKRANKUNGEN UND MEDIKAMENTE

Bitte unbedingt angeben

- Blutverdünner: Marcumar, Xarelto, Eliquis, Lixiana, Pradaxa, ASS-Dauermedikation, Clopidogrel
- Bisphosphonate, Denosumab, Romosozumab oder Antiangiogenika
- Diabetes, Immunsuppression, Kortison-Dauertherapie
- Bestrahlung im Kopf-Hals-Bereich
- Herzklappenersatz, Endokarditis-Risiko, relevante Allergien

Warum das wichtig ist

Diese Faktoren verändern Blutungs-, Infektions- oder Wundheilungsrisiken. Antiresorptive Medikamente können selten eine Kieferknochennekrose begünstigen. Blutverdünner dürfen nicht eigenständig abgesetzt werden; die Anpassung erfolgt nur nach ärztlicher Abstimmung.

8 · VERHALTEN NACH DEM EINGRIFF

Erste Stunden

- Auf den Tupfer 30-60 Minuten konstant aufbeißen
- Oberkörper erhöht lagern und körperlich ruhen
- Nicht ständig nachsehen, nicht spucken, nicht kräftig spülen
- Erst essen, wenn die Betäubung vollständig abgeklungen ist

Kühlen und Schonung

- Feucht und mild kühlen, kein Eispack direkt auf die Haut
- Kühlintervalle: etwa 10 Minuten kühlen, 10 Minuten Pause
- Am OP-Tag Ruhe, kein Sport, kein schweres Heben
- Für 7-10 Tage Belastung nach Verlauf reduzieren

Blutpfropf schützen

- Kein Strohhalm, keine Sportflasche mit Sog
- Nicht an der Wunde saugen oder mit der Zunge manipulieren
- Kein Alkohol, Nikotin, Kaffee oder Energydrinks für mindestens 3-5 Tage
- Weiche, kühle oder lauwarme Kost bevorzugen

9 · SCHMERZMITTEL UND MUNDHYGIENE

Schmerztherapie

Mittel	Einnahme	Hinweis
Ibuprofen 600	Alle 6-8 Std., max. 3x/Tag	Nicht nüchtern
Paracetamol 500-1000	Alternativ/ergänzend alle 6 Std.	Max. 4 g/Tag
Novalgin-Tropfen	Bis zu 4 x 30 Tropfen täglich	Bei stärkeren Schmerzen
Kein Aspirin/ASS	Absolut meiden	Blutverdünnend, Nachblutungsgefahr

Tipp: Falls Sie bereits ein Rezept erhalten haben, kann die erste Schmerztablette etwa 1 Stunde vor dem Eingriff sinnvoll sein. Danach nehmen Sie Schmerzmittel nach Plan und nicht nüchtern ein.

Mundhygiene

Putzen Sie die übrigen Zähne vorsichtig weiter, sparen Sie die Wunde zunächst aus. Am OP-Tag nicht kräftig spülen oder gurgeln. Ab dem Folgetag kann eine Mundspülung oder ein lauwarmes Salzwasser-Mundbad sanft verwendet werden, wenn es Ihnen empfohlen wurde.

■ **Keine Munddusche:** Verwenden Sie keine Munddusche und keine Spülspritze, außer wir haben Ihnen das ausdrücklich gezeigt oder mitgegeben.

10 · LÜCKE UND SPÄTERE VERSORGUNG

Implantat

Ein Implantat ersetzt die Zahnwurzel und trägt später die Krone. Dafür muss ausreichend Knochen vorhanden sein. In manchen Fällen ist Alveolenmanagement oder späterer Knochenaufbau sinnvoll.

Brücke

Eine Brücke kann eine festsitzende Alternative sein. Häufig müssen dafür Nachbarzähne beschliffen werden. Die Planung erfolgt mit dem Hauszahnarzt.

Prothese oder keine Versorgung

Eine herausnehmbare Versorgung oder zunächst keine Versorgung kann je nach Situation sinnvoll sein. Langfristig können Nachbarzähne kippen oder wandern, wenn eine Lücke offen bleibt.

■ **Frontzahnücke:** Wenn eine sichtbare Lücke entsteht und Sie ein Provisorium wünschen, muss dieses vor dem Extraktionstermin vom Hauszahnarzt vorbereitet werden. Bitte stimmen Sie das frühzeitig dort ab.

11 · ZEITPLAN DER HEILUNG

0 OP-TAG Tupferdruck, Ruhe, milde Kühlung, weiche Kost
1-2 TAGE Schwellung und Wundgefühl möglich
3-5 TAGE Trockene Alveole zeigt sich typischerweise in diesem Zeitraum
7-10 TAGE Kontrolle oder Fadenentfernung, falls vernäht
2-6 WOCHEN Weichgewebe stabilisiert sich
3-6 MONATE Knochen füllt sich je nach Defekt weiter auf

12 · HÄUFIGE FRAGEN

Tut die Zahnentfernung weh?

Während des Eingriffs nicht. Sie spüren Druck und Bewegung. Wenn Sie Schmerz spüren, geben Sie sofort ein Handzeichen; dann wird nachbetäubt.

Muss immer genäht werden?

Nein. Bei einfachen Extraktionen heilt die Wunde oft ohne Naht. Bei operativer Entfernung, MAV-Risiko, Blutungsrisiko oder größerer Wunde wird eher genäht.

Wie lange bin ich eingeschränkt?

Nach einfacher Extraktion oft 1-2 Tage, nach operativer Entfernung eher mehrere Tage. Körperliche Arbeit, Sport und Sauna sollten je nach Verlauf pausiert werden.

Was ist eine trockene Alveole?

Der Blutpfropf schützt die Wunde. Wenn er fehlt oder zerfällt, liegt Knochen frei. Das ist schmerzhaft, aber behandelbar. Typisch sind zunehmende, ausstrahlende Schmerzen ab Tag 2-5.

Wann darf ich wieder essen?

Erst wenn die Betäubung vollständig abgeklungen ist. Beginnen Sie mit weicher, kühler oder lauwärmer Kost und kauen Sie nicht direkt auf der Wunde.

Wer plant den Zahnersatz?

Die definitive Versorgung wird in der Regel mit dem Hauszahnarzt geplant. Wir besprechen, ob chirurgisch etwas für die spätere Versorgung vorbereitet werden sollte.

Sofort melden oder abklären lassen bei ...

- **Starker Nachblutung**, die trotz 30 Minuten konstantem Druck nicht nachlässt
- **Zunehmenden Schmerzen** ab Tag 2-5 trotz Schmerzmittel
- **Fieber** über 38,5 °C oder länger als 2 Tage
- **Eiter, üblem Geruch oder schlechtem Geschmack**
- **Zunehmender Schwellung** nach anfänglicher Besserung
- **Anhaltender Taubheit** an Lippe, Kinn oder Zunge
- **Flüssigkeit aus der Nase** nach Oberkiefer-Seitenzahnextraktion
- **Starker Schluckbehinderung oder Atemnot**

Bei Problemen nach dem Eingriff zuerst unsere postoperative Notfallnummer nutzen. Wenn wir nicht erreichbar sind: zahnärztlicher Notdienst 01805 60 70 11. Nur bei lebensbedrohlicher Notlage, Atemnot, starker Schluckbehinderung oder raschem Anschwellen von Mundboden, Hals oder Zunge: sofort 112 rufen.

13 · CHECKLISTE VOR IHREM TERMIN

- ☐ Diese Seite vor dem Termin einmal vollständig lesen
- ☐ Aktuellen Medikamentenplan und bekannte Allergien bereithalten
- ☐ Blutverdünner, Bisphosphonate/Denosumab, Diabetes, Immunsuppression oder Bestrahlung angeben
- ☐ Röntgenbild oder Überweisung mitbringen, falls noch nicht übermittelt
- ☐ Bei sichtbarer Lücke: Provisorium rechtzeitig mit dem Hauszahnarzt organisieren
- ☐ Schonung, weiche Kost und ggf. Begleitperson einplanen
- ☐ Bei Dämmer Schlaf oder Vollnarkose: Nüchternheitsregeln einhalten und Abholung aus der Praxis organisieren

PRAXIS · RÜCKFRAGEN

06151 786540

info@mkg-im-carree.de

Nach dem Eingriff erhalten Sie unsere postoperative Notfallnummer. Wenn wir nicht erreichbar sind: zahnärztlicher Notdienst 01805 60 70 11.